Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent16vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5175501-49.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: VIVI JOSE PONTEL

AUTOR: JANDYRA DE LOURDES BRESSAN PONTEL

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

RÉU: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

Vistos.

VIVI JOSE PONTEL e JANDYRA DE LOURDES BRESSAN PONTEL ajuizou *"Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência"* em desfavor de UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.

Narrou a autora Jandyra, idosa de 81 anos, ser beneficiária, em conjunto com seu marido Vivi, de plano de saúde fornecido pela Unimed Porto Alegre. Alegou ser portadora de Síndrome Mielodisplásica (SMD), desenvolvida em decorrência de tratamentos oncológicos anteriores, necessitando da administração contínua do medicamento Aranesp 500 mcg/ml, conforme prescrição médica, sob pena de progressão da enfermidade para leucemia. Afirmou que, embora esteja em dia com as obrigações contratuais, a requerida recusou-se a custear o tratamento sob a justificativa genérica de ausência de cobertura contratual, decisão que foi mantida mesmo após a interposição de recurso administrativo. Sustentou que a negativa da Unimed caracteriza prática abusiva, em flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável em virtude da natureza consumerista da relação. No que tange à tutela de urgência, argumentou que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, dada a gravidade do quadro de saúde da autora e os riscos de progressão para leucemia. Requereu, assim, a concessão imediata da tutela para obrigar a requerida a autorizar e custear o fornecimento do medicamento Aranesp 500 mcg/ml, sob pena de multa diária. Postulou, ao final, a condenação definitiva da ré ao custeio do tratamento.

Recolhidas as custas, foi recebida a inicial e indeferido o pedido de tutela provisória de urgência (evento 5, DESPADEC1).

Os autores agravaram da decisão, sendo concedida a liminar pelo Tribunal de Justiça (processo 5198156-67.2022.8.21.7000/TJRS, evento 40, ACOR1).

Citada, a ré **UNIMED PORTO ALEGRE** contestou alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a relação contratual dos autores é mantida com a Central Nacional Unimed, pessoa jurídica distinta, inscrita no CNPJ sob o nº 02.812.468/0001-06, com sede em São Paulo/SP. Argumentou que as cooperativas que compõem o sistema Unimed possuem autonomia administrativa e financeira, e que a Unimed Porto Alegre não possui conhecimento sobre os termos do contrato firmado com os demandantes ou sobre a negativa de cobertura do medicamento pleiteado. No mérito, a contestante reforçou que não há relação jurídica entre os autores e a Unimed Porto Alegre, pois não participou da contratação, não expediu a negativa de cobertura e não possui ingerência sobre os termos do contrato firmado com a Central Nacional Unimed. Asseverou, ainda, que apenas a Central Nacional Unimed possui legitimidade para discutir os pedidos formulados. Ao final, requereu, em sede preliminar, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Unimed Porto Alegre e a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, no mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos formulados (evento 17, CONT1).

A **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL** compareceu aos autos e pugnou pela retificação do polo passivo, para que conste exclusivamente a CENTRAL NACIONAL UNIMED como ré, excluindo-se a UNIMED PORTO ALEGRE. Ainda, impugnou o valor atribuído à causa, alegando que a quantia fixada pela autora carece de embasamento jurídico e técnico, inexistindo laudos ou orçamentos que justifiquem o montante de R$ 75.420,00, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sucessivamente, caso não acolhida a impugnação, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base no art. 85, § 8º, do CPC. No mérito, sustentou a inexistência de obrigação contratual para cobertura do medicamento pleiteado, argumentando que o contrato firmado com a autora, de plano coletivo empresarial não adaptado à Lei 9.656/98, rege-se por normas vigentes à época de sua celebração, sendo inaplicável o rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela ANS. Argumentou que a previsão contratual delimita claramente os riscos cobertos e exclui medicamentos de uso domiciliar. Acrescentou que cláusulas limitativas, desde que claras e de fácil compreensão, são válidas e não abusivas, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. Aduziu que o medicamento ARANESP 500 MCG/ML não possui eficácia comprovada para a patologia da autora, não preenche as Diretrizes de Utilização (DUT) nº 65 do rol da ANS e não está listado como cobertura obrigatória. Reiterou que o contrato firmado é válido e eficaz, que as cláusulas excludentes respeitam a legislação vigente e que a negativa de cobertura não configura abusividade ou ilicitude, requerendo, assim, a improcedência da demanda (evento 24, CONT1).

Houve réplica (evento 25, DOC1).

A parte autora não concordou com a exclusão da UNIMED PORTO ALEGRE, pois a antecipação de tutela foi contra ela deferida (evento 34, PET1).

A CENTRAL UNIMED noticiou que, em contato com a filha dos autores, obteve a informação de que o médico responsável pelo acompanhamento de JANDYRA não está mais prescrevendo a medicação postulada, razão pela qual postula a revogação da decisão liminar concedida e, consequentemente, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (evento 51, PET1).

Intimada, a autora informou que devido à demora no cumprimento da decisão judicial, houve necessidade de alteração no tratamento pela equipe médica. Disse que a negativa de cobertura e o atraso no cumprimento da liminar causaram prejuízos à saúde da requerente, agravando sua condição e necessidade de intervenção médica emergencial (evento 62, PET1).

Em saneador, foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED PORTO ALEGRE, sendo determinada a sua manutenção e a da CENTRAL no polo passivo (evento 64, DESPADEC1).

Instadas, as partes não manifestaram interesse na produção de provas.

A instrução foi encerrada (evento 76, DESPADEC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo questões pendentes ou vícios a serem sanados ou mesmo necessidade de produção de provas em audiência, cabível o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC.

Consigno, de plano, que a presente análise ocorre independentemente da ordem cronológica de conclusão, prevista no artigo 12, §4º, do Código de Processo Civil, pois a autora JANDYRA possui 84 anos de idade, enquadrando-se na prioridade especial de julgamento prevista no art. 71, §5º, do Estatuto do Idoso.

Primeiramente, impõe-se afastar a hipótese de extinção da ação sem resolução de mérito quanto ao fornecimento da medicação. A autora pleiteou a concessão de provimento jurisdicional que determinasse à operadora demandada o fornecimento do medicamento Aranesp 500 mcg/ml, conforme prescrição médica, sob pena de progressão da enfermidade para leucemia.

Na hipótese, após o deferimento do pedido em sede de tutela provisória, a autora fez uso do fármaco, custeado pela UNIMED, a partir de dezembro de 2022. Posteriormente, em setembro de 2023, a filha dos autores informou que a medicação havia sido suspensa pelo médico que acompanha o tratamento da genitora (evento 51, OUT2).

Assim, a hipótese não é de perda do objeto, sendo necessária a análise do mérito, para confirmação ou não da tutela de urgência e verificação da obrigação do réu quanto à entrega do fármaco, razão pela qual rejeito a alegação de extinção do processo sem resolução.

Com relação à ilegitimidade passiva, foi refutada em decisão de saneamento do processo, a qual se alinhou ao decidido pelo Tribunal de Justiça quanto à legitimidade da UNIMED PORTO ALEGRE, em sede de agravo de instrumento.

Por fim, no tocante à preliminar de impugnação ao valor da causa, destaco que deve ser afastada, isso porque a parte autora pretende a obtenção de tratamento de saúde e o valor atribuído à causa (R$ 75.420,00) é correspondente ao custo anual do tratamento, de forma privada.

Portanto, não se pode considerar inadequado que corresponda ao montante atribuído à causa, mormente por força do disposto no artigo 292, §2º, do CPC:

> *Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...)*
>
> *VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; (...)*
>
> *§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.*

Nesse sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DERMATITE ATÓPICA (CID 10: L20). MEDICAMENTO DUPILUMABE. VALOR DA CAUSA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO. ARTIGO 292 § 2º DO CPC 1) Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora busca cobertura do medicamento Dupilumabe, porquanto diagnosticada com dermatite atópica (CID 10: L20), julgada procedente na origem. 2) Os artigos 291 e 292 do CPC definem que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que o conteúdo econômico desta seja indeterminado, e as diretrizes para fixação desse valor. 3) No parágravo 2º do artigo 292 do CPC, há previsão de que O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. 4) Nas causas em que se busca a cobertura de tratamento médico, afigura-se cabível atribuir à causa - ou considerar no montante a ser atribuído - o valor referente ao custo de uma prestação anual do tratamento, com fulcro no arttigo 292 § 2º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA (Apelação Cível, Nº 50397255020228210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 21-03-2024).*

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Trata-se de "*Ação Ordinária*", em que a parte autora postulou o deferimento de liminar, de modo a obrigar a ré a fornecer o medicamento requisitado pelo médico e descrito na inicial: *Aranesp* 500 mcg/ml. Não há controvérsia acerca da contratação do plano de saúde, tampouco da negativa da ré em fornecer o medicamento extrajudicialmente, assim como de

ser a autora portadora da moléstia mencionada.

Cinge-se a controvérsia, portanto, sobre a possibilidade de negativa quanto à cobertura do medicamento que necessita a autora, ao argumento de que o fármaco solicitado não se enquadra no rol de procedimentos da ANS para a patologia da autora.

Inicialmente, destaca-se que o caso deve ser apreciado levando-se em conta o disposto no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

> *Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.*
>
> *§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.*
>
> *§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

A questão resta pacificada na Súmula nº **469 do STJ:**

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.".*

Assim como na Súmula nº **608 do STJ:**

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".*

No que se refere à alegação de que o plano da autora não se enquadra nas disposições da Lei nº 9.656/1998, conforme entendimento sedimentado pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com repercussão geral, os contratos celebrados antes da vigência da Lei 9.656/1998, que não tenham sido adaptados, se caracterizam como ato jurídico perfeito, com plena validade de suas disposições, conforme fixado no julgamento do Tema 123:

> ***As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados[1].***

Portanto, em se tratando de contrato de plano de saúde firmado anteriormente à vigência da Lei n.º 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, a regra é que não seja aplicável a mencionada legislação, salvo em casos de extrema urgência e risco de morte, em que a negativa se torne excessivamente desproporcional ao consumidor, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, criado a partir do julgamento do RE n.º 948634, julgado em 20/10/2020:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - **A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.** VI - **Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.** VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A **vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.** X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. Tema 123 - Aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados. Tese:* ***As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.***

No caso em apreço, resta comprovado que o tratamento postulado se mostrava imprescindível e urgente para o tratamento da doença que acometeu a consumidora, conforme documentos acostados à inicial, em especial o laudo médico, que evidencia a gravidade da doença e ressalta que o tratamento com o medicamento requerido é o adequado devido ao histórico de neoplasias e à idade da paciente (evento 12, ATESTMED2):

> Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado, que Jandyra de Lourdes Bressan Pontel, portador do RG 7003436768, está realizando investigação de anemia. Diante de todos os exames realizados pela paciente, as principais possibilidades (todas de origem neoplásica) incluem: gamopatia monoclonal de significado renal, doença renal crônica com anemia secundária e gamopatia monoclonal e, mais provavelmente, síndrome mielodisplásica secundária à quimioterapia realizada anteriormente pela paciente em 2011 e 2018 por entidades oncológicas distintas. Para todas estas condições da paciente, o tratamento quimioterápico é muito tóxico pela idade e pelo grau de acometimento da doença hematológica atual. Desta forma, fica preconizado para todos os pacientes com síndrome mielodisplásica (CID10 D46.9) que não são elegíveis a quimioterapia de alta intensidade, o tratamento direcionado adjuvante com fatores estimuladores de colônia, entre eles, a eritropoetina (aranesp), visto que paciente apresenta anemia sintomática.

Nestes termos, mostra-se inadmissível que a requerida tenha se contraposto à cobertura ao tratamento prescrito à autora, indispensável para o tratamento da doença que lhe acometia. Ademais, considerando a imprescindibilidade do tratamento naquela época, deve prevalecer a cobertura contratual de modo genérico, sob pena de consideração como abusiva a cláusula ou interpretação restritiva à luz do artigo 54 do CDC.

Além disso, a tese de ausência de cobertura por falta de previsão no rol da ANS não prospera, haja vista ter sido superada pelo STJ, que apregoou a impossibilidade de limitação de cobertura de tratamentos neoplásicos, sendo indiferente a existência de previsão no rol da agência reguladora, dada as características específicas de elaboração da listagem para tais medicamentos.

No caso em apreço, a Unimed justificou a negativa de cobertura com base na Diretriz de Utilização Técnica nº 65 da ANS, a qual regula o fornecimento de terapias antineoplásicas para tratamento do câncer, dispondo de um rol de substâncias ativas cobertas e de um rol de indicações de uso, sendo obrigatória somente a cobertura dos medicamentos listados para as indicações de uso ali constantes, sendo que o medicamento solicitado pela autora não está enquadrado na referida Diretriz.

Ressalto, de plano, que a justificativa apresentada pela Unimed não comporta acolhimento. Embora não desconheça a existência da Resolução estabelecendo critérios objetivos para a cobertura, não se pode esquecer que a medicina não é uma ciência exata, possuindo cada caso clínico as suas peculiaridades e necessidades.

Com efeito, incumbe ao médico estabelecer qual o melhor tratamento a ser prescrito, de acordo com as peculiaridades da patologia de cada paciente, não sendo dado à operadora do plano de saúde negar a cobertura com base em rol exemplificativo e genérico.

Nessa senda decisão do Tribunal de Justiça especificamente quanto ao medicamento solicitado nestes autos:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.* ***ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. DEVER DE COBERTURA.*** *. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. -* ***Legitimidade passiva Unimed. O STJ tem entendimento claro a respeito da aplicação da Teoria da Aparência no caso em comento. A jurisprudência do STJ "reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor". Conforme ressalta a Corte Superior, considerando que várias sociedades explorem a mesma marca, embora com CNPJs e personalidade jurídica diversos, todas respondem solidariamente pelas obrigações contratadas por quaisquer delas. Legitimidade passiva declarada.*** *- Mérito. Caso em que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois comprovada a probabilidade do direito invocado e, ainda, a urgência no atendimento do pleito, pois demonstrada a moléstia que acomete a parte autora da ação, inclusive, com grave risco de vida. -* ***Decisão reformada para determinar o fornecimento do médicamento ARANESP 500 MCG/ML, considerando a demonstração da contratação do plano de saúde e a moléstica grave que acomete a agravante - neoplasia*** *- com majoração da multa diária antes cominada, considerando a notícia de descumprimento injustificado da determinação judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51981566720228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-11-2022.*

Nesse sentido, corroborando o acima exposto, de que o rol de critérios para a cobertura de procedimentos/medicamentos previstos pela ANS é apenas exemplificativo, cabendo ao médico estabelecer qual o procedimento mais adequado ao caso, são os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça:

> *CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO* ***CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA****. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.* ***Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.*** *Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.057.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).*
>
> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAZOPANIBE (VOTRIENT). NEOPLASIA MALIGNA TIPO LEIOMIOSSARCOMA DE ORIGEM UTERINA COM RECIDIVADA EM PULMÕES E ABDÔMEN. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO VERIFICADOS. NO CASO CONCRETO, DEMONSTRADO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TENDO EM VISTA O RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA.* ***DESCABIDA A NEGATIVA DE FORNECIMENTO, POIS INCUMBE AO MÉDICO PRESCREVER O TRATAMENTO. DIREITO AMPARADO NO ART. 12, I, "C", DA LEI N° 9.656/98 QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL COMO PROCEDIMENTO DE COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE****. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50288633120248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 24-04-2024)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PACIENTE COM CÂNCER DE RIM. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. Obrigação de fazer. Fornecimento dos medicamentos PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE. Tratamento de câncer de rim. Em regra, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é taxativo, não podendo ser exigidos das operadoras de plano de saúde, portanto, a cobertura dos tratamentos ali não previstos. ***Entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no entanto, admite mitigações, sobretudo após alterações da Lei nº 14.454/2022. Caso dos autos em que o autor foi diagnosticado com "Câncer de rim, Cid c64", razão pela qual necessita fazer uso do tratamento combinado dos medicamentos PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE. Com efeito, o artigo 12 da Lei nº 9.656/98 elencou os medicamentos antineoplásicos dentre as coberturas obrigatórias, ainda que para tratamento domiciliar. Tampouco a alegação de que a negativa de cobertura teve por fundamento o uso off label (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento) merece prosperar, uma vez que é considerada abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). Entendimento do STJ.*** *Assim, é devido o fornecimento do medicamento.* ***(...)*** *Precedentes desta Câmara. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários advocatícios. Recurso que vai parcialmente provido, a fim de majorar os honorários fixados na origem, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, por apreciação equitativa. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ UNIMED E DERAL PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOA UTOR, A FIM DE MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Apelação Cível, Nº 50249805820238210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-04-2024) .*

Ademais, é entendimento do STJ que os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças que receberão cobertura, mas não o tipo de tratamento, o qual é de competência do médico que acompanha o paciente, consoante se extrai do voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:

> *"A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde.* ***De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor.*** *Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02)".*

Destarte, era dever da demandada fornecer o tratamento pleiteado, sem a necessidade de intervenção judicial, sendo a procedência do pedido medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, e para fins do art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por VIVI JOSE PONTEL e JANDYRA DE LOURDES BRESSAN PONTEL em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL** para tornar definitiva a tutela liminar de urgência (processo 5198156-67.2022.8.21.7000/TJRS, evento 40, ACOR1), determinando às demandadas que forneçam o medicamento Aranesp 500 mcg/ml enquanto necessário ao tratamento.

Sucumbentes, arcarão as demandadas com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, § 8°,do CPC.

Publicada, registrada e intimadas as partes via sistema.

Sobrevindo recurso(s) de embargos de declaração, dê-se vista à parte oposta, por cinco dias. Depois, voltem para análise.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) apelada(s) para, em quinze dias, apresentar(em) contrarrazões. Caso haja recurso adesivo ou suscitação de questões preliminares (artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil) em contrarrazões, dê-se vista ao(s) apelante(s) por novos quinze dias, para manifestação.

Concluídas as intimações e decorridos os prazos, remeta-se o feito ao E.Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se pelo lançamento do correspondente movimento no sistema Eproc.

Verifiquem-se as custas finais.

Após, nada mais sendo requerido, e não subsistindo pendências, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **GEOVANNA ROSA, Juíza de Direito**, em 24/01/2025, às 10:13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10075468792v20** e o código CRC **f2316946**.

---

1. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020) ↩